

Интраоперационная ультразвуковая сонография в выявлении распространенности рака желудка

Ельчибаев Б.М., Берилова Г.А., Мурина Н.А., Салиев З.С.

Кафедра госпитальной хирургии

Семипалатинской государственной медицинской академии

УДК 616.33-006-03

Интраоперационная ультразвуковая сонография в выявлении распространенности рака желудка.

В работе приведен опыт интраоперационного ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости и анализ непосредственных результатов исследования 32 больных раком желудка при гастрэктомии. Для оценки глубины опухолевой инвазии в стенку желудка и определение степени распространения в лимфоколлекторы желудка осуществлялось интраоперационное УЗИ с помощью современного переносного сканера фирмы «Shymadzu SDU-350FA» с линейным датчиком частоты 5-7,5 MHz.

В оценке глубины инвазии симптом «повышенной эхогенности просвета желудка» выявлено у 27 (84,3%) больных. Интраоперационное УЗИ стенки желудка позволило решить вопрос об объеме выполнения

операции.

Эффективность выполненной операции определяли как непосредственными результатами, так и функциональным состоянием пищеводно-тонкокишечного анастомоза. Например, при локализации опухоли в антральном отделе желудка у 14 (43,7%) больных в средней трети желудка и выше, установлено отсутствие послынности и перистальтики стенки или ее замедление. Объем операции у данной категории больных был расширен и выполнена радикальная гастрэктомия.

Использование интраоперационного ультразвукового исследования значительно расширяет возможности этого метода с целью выявления регионарных метастазов и распространенности по его стенке и выполнения адекватного объема резекции и лимфодиссекции.

Введение

Проблема ранних рецидивов после хирургического лечения рака желудка по-прежнему находится в центре внимания хирургов, хотя в последние годы повсеместно отмечается уменьшение частоты его заболеваемости. Пятилетняя общая выживаемость составляет 18,7%. Основные надежды на улучшение отдаленных результатов лечения данной категории пациентов связаны, прежде всего, с адекватным хирургическим лечением и выполнением расширенных лимфодиссекции [1, 2, 3]. Основным фактором, определяющим прогноз у больных раком желудка, является степень распространенности опухолевого процесса, т.е. глубина инвазии в стенку органа, а также метастатическое поражение лимфоузлов. [2, 4, 6.]. Таким образом, одним из важных прогностических факторов определяющим тактику и объем оперативного лечения является распространенность опухолевого процесса. Зачастую хирург степень распространения опухоли в стенку, а также в основные лимфоколлекторы желудка определяет пальпаторно и визуально, но для проведения необходимого объема операции с лимфодиссекцией оценка процесса «на глаз» недостаточно, так как последние иммуногистохимические исследования при раке тела желудка показали, что метастазы обнаруживались в лимфоузлах в 4 раза чаще, чем при гистологическом исследовании. В настоящее время в связи с появлением новых аппаратов и расширением возможностей ультразвукового сканирования, все чаще этот метод исследования стал использоваться клинической практике, для визуализации опухолевого процесса [5, 6, 7]. С внедрением в последние годы в нашу практику интраоперационной эхолокации внутренних органов и лимфоколлекторов значительно расширились возможности для правильного определения степени распространенности опухолевого процесса и улучшения качества операции. Во время операции при раке желудка появилась реальная возможность оценки глубины опухолевой инвазии в стенку этого органа, лимфогенного распространения, а

также возможной диссеминации опухолевого процесса по капсуле печени и брюшине. Все это послужило поводом к проведению данного исследования.

Материалы и методы

В работе приведен опыт интраоперационного ультразвукового исследования (УЗИ) с органов брюшной полости и анализ непосредственных результатов исследования у 32 больных при гастрэктомии по поводу рака желудка, оперированные по разработанной методике клиники за период 2001-2008гг. В этой группе мужчин было 23 (71,9%), женщин- 8 (28,1%) в возрасте от 22 до 74 лет. После лапаротомии и проведения интраоперационной визуальной, а также пальпаторной ревизии органов брюшной полости для оценки глубины опухолевой инвазии в стенку желудка и определения степени распространения в лимфоколлекторы желудка, осуществлялся интраоперационное УЗИ с помощью современного переносного сканера фирмы «SHYMADZU» SDU-350A с линейным датчиком частотой 5-7,5 MHz.

Результаты и обсуждение

При интраоперационном ультразвуковом исследовании органов брюшной полости линейный датчик 5-7,5 MHz позволил четко визуализировать все расположенные в глубине 2,5-3,5 см очаговые аномалии, особенно в стенке и лимфоколлекторах желудка, как перигастральных, так и экстрагастральных лимфоузлах. Важной особенностью интраоперационного УЗИ явилось совершенно четкая визуализация всей толщи паренхимы печени, что меняло тактику лечения в некоторых случаях, когда обнаружены по краю печени, поверхностно расположенные единичные метастазы. В таких случаях выполнены комбинированные операции с атипичической резекцией пораженного участка печени. Хирургическая тактика лечения также менялось при получении данных интраоперационного УЗИ, когда

опухоль прорастает в соседние органы (поджелудочная железа, поперечно-ободочная кишка). В оценке инвазии опухоли в стенку желудка определялось точная глубина и площадь поражения. Зачастую характерными экзосимптомами бластоматозного процесса желудка явилось ассиметричное утолщение его стенки в виде образования изоэхогенной природы с неровными контурами, иногда определялся край кратера при блюдцеобразном раке, этот симптом нами выявлено у 12(37,5%) больных. В оценке глубины инвазии симптом «повышенной эхогенности просвета желудка» выявлено у 27 больных, что составило 84,3%. Во всех наблюдениях была выполнена оценка состояния слоев стенки в месте опухоли. Установление границы опухолевого распространения по стенке желудка визуальное и пальпаторно очень затруднительно, особенно это важно при решении вопроса объема выполнения операций. Интраоперационное УЗИ стенки желудка позволило решить данную проблему. Итак, при локализации опухоли в антральном отделе желудка у 14 (43,7%) больных в средней трети желудка и выше, установлено отсутствие послойности и перистальтики стенки или ее замедление, а также определялся плоский гиперэхогенный участок, указывающие на интраорганный опухолевый распространение. При макроскопическом обследовании в данных областях создавалось впечатление нормальной стенки желудка. Объем операции у данной категории больных был расширен и выполнена радикальная гастрэктомия. При патогистологическом исследовании удаленного препарата констатирован факт наличия опухолевой инфильтрации в теле желудка, таким образом, подтверждена высокая информативность интраоперационного ультразвукового исследования

В лимфоколлекторах желудка метастатическое поражение лимфатических узлов при интраоперационном УЗИ определялось, как эконегативное образование с четкими контурами и обнаружено: в перигастральных - у 28 (87,5%) больных, в области левой желудочной артерии, чревного ствола, общей печеночной артерии и ворот селезенки в 22 (68,7%) случаях, ретропанкреатодуоденальные и по ходу печеночно-двенадцатиперстной связки – 2 (6,2 %), парааортальные – 1 (3,1%) наблюдениях. Учитывая распространенность опухолевого процесса в лимфоколлекторы желудка, произведены гастрэктомии с лимфодиссекцией: D2- 29, D3-2, D3 + PALD- 1 случаях. При этом эндофитные (инфильтративные) формы выявлены у 19(59,3%) больных, экзофитный (полиповидный,

блюдцеобразный) наблюдали у 11 (34,3%), смешанные (язвенно-инфильтративные) встречались у 2 (6,4%).

При инфильтративном типе роста преобладали следующие гистологические формы аденокарцином: низкодифференцированная и недифференцированный рак у 16(50%), перстневидно-клеточная – у 4(12,5%) и слизеобразующая – у 1(3,1%) больных. Экзофитные формы гистологически представлены 8 (25%) случаями низкодифференцированной аденокарциномы и 3 (9,4%) случаев перстневидно-клеточного рака.

В послеоперационном периоде осложнения связанные с расширенной лимфодиссекцией отмечались в 3 (9,4%) случаях в виде лимфорей, которые были купированы на 7-8 сутки после операции, летальности не было.

Таким образом, использование интраоперационного ультразвукового исследования, значительно расширяют возможности этого метода, с целью выявления регионарных метастазов и распространенности по его стенке и выполнения адекватного объема резекции и лимфодиссекции.

Выводы

1. Применение интраоперационного ультразвукового исследования позволяет выявить непальпируемые метастазы в лимфоколлекторах желудка.
2. Уточнение интраорганный распространения опухоли позволяет определить адекватный объем операции при раке желудка.

Литература

1. Арзыкулов Ж.А., Турекеев Б.А., Ижанов Е.Б. Современный стандарт лечения рака желудка // Мат. респ. научно - практич. семинара: «Совр. возможности клинической онкологии» - Астана, 2004.- С.181-184.
2. Серов В.В.// Клиническая морфология и прогноз рака желудка. М. Медицина, 2000. С.16
3. Давыдов М.И., Германов А.Б., Стилиди И.С. // Хирургия .- 1995.-N-5 С.41-46.
4. Горшков А.Н., Мешков В.М., Грачева Н.И. Возможности лучевых методов исследования (УЗИ, КТ) в предоперационной оценке внутрисстеночной инвазии рака желудка // Вестник рентгенологии – 2000.-№2.- С.27-34.
5. Вашкамадзе Д.П., Шипуло Н.В. Ультразвуковое исследование для определения степени распространения рака проксимального отдела желудка // Сов.мед.-1991.-№6.-С.63-66.
6. Стилиди И.С. Рак желудка // Врач.-1999.-№7.- С.10-13.
7. Maehara Y., Tomisaki S., Emi et al.// Anticancer Res.- 1995.- Vol. 15, №3 - P. 1049-1053.